

4 - 03- Les tumeurs malignes des maxillaires - Pr. El Bouihi

On va enchaîner rapidement les tumeurs malignes des maxillaires. Vous allez voir que vous avez retenu l'essentiel du propos précédent. Le reste sera juste une image en miroir et un complément d'un certain nombre de choses qu'on va voir au chapitre précédent.

Alors, on revient à la case de départ. C'est une tumeur maligne qui se développe au niveau des maxillaires. Pareil, on va exclure les tumeurs sinusiennes.

On va exclure une autre entité, c'est les tumeurs gingivos maxillaires à point de départ muqueux. Parce que quand un patient vient vous voir, il a un bourgeon au niveau de la bouche. On ne sait pas si c'est la tumeur qui est à l'intérieur qui s'est extériorisée.

Où là, c'est une tumeur gingivale qui a envahi l'os. D'ailleurs, l'entité, je vais anticiper. L'entité alvéolodentaire, c'est une entité qui est bien particulière.

C'est-à-dire que l'entité alvéolodentaire est la seule tumeur qui est collée à l'os sans tissu conjonctif interposé. C'est-à-dire que les muqueuses sont un tissu conjonctif sous-jacent avant de passer à un autre tissu. Donc, notamment, il faudrait un os.

Mais la gingive attachée, elle, au niveau de la bouche, c'est la seule muqueuse qui est collée à l'os sans tissu conjonctif. Deuxième chose, c'est qu'on a le collé dentaire. Le collé dentaire, il est à la fois, quand il est bien fait et quand il est sain, c'est un bouchon hermétique qui fait séparer le milieu extérieur par rapport à l'organisme.

Mais le collé, lui, peut être source de problème. Et lui, c'est une zone de faiblesse. Imaginez que vous avez une tumeur à ce niveau-là, au niveau de la chancive.

Elle a tendance à rentrer dans l'os directement par voie alvéolaire. Donc, il va s'incruster. Il va rogner le ligament desmodontal ou alvéolodentaire et se retrouver directement dans l'os.

Qu'est-ce que cela impose? Impose le fait que toute tumeur gingivale, elle est potentiellement et rapidement osseuse si on a une dent qui est sur place. Donc, on peut avoir un T1, c'est une tumeur qui est inférieure à 2 cm. 3 cm, elle rentre dans l'os.

Deuxièmement, T1, T4. D'accord? Donc, il y a un seuil de stades tumoraux qui est rapide. C'est pour ça que ces tumeurs gingivomandibulaires sont de mauvais pronostics.

Ils évoluent rapidement. Ils sont potentiellement mortels. Donc, on va exclure normalement les tumeurs sinusiennes par le même principe.

Et même si le fait que ces tumeurs gingivomaxillaires, donc quand on dit gingivomaxillaire, on sous-entend les tumeurs gingivales avec envahissement osseux, on va les inclure parce que c'est la même entité. On ne sait pas si c'est de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers

l'intérieur. D'accord? Donc, simbiologiquement, c'est la même chose.

Après, l'histologie, c'est une autre histoire. Je termine en fin de touche. D'accord? Alors, on ne va pas s'attarder dessus.

Là, on a parlé de l'unité gingivo-alvéolaire. Pour vous dire que toute tumeur gingivale, elle fait un saut de stade rapidement par cette zone de faiblesse, donc c'est l'alvéole. D'accord? Pour vous dire aussi que quand on a une tumeur maligne, c'est tellement rapidement évolutif que la dent saute.

Elle n'a plus de soutien, elle saute. C'est un signe de bénéalité. Là, la perte de dents saine.

Et donc ça commence à faire mal et une dente qui saute. C'est un signe de maladie de l'hémorragie. Même si ça ne saute pas, on a le soutien parodontal qui disparaît.

Donc, à la radiologie, on a des dents qui sont à l'aspect de dents flottantes. Vous pouvez le voir. D'accord? Autre notion à ne pas perdre de vue, c'est que la cavité orale a un effet zétiologie de muqueuse qui est truffée de glandes salivaires accessoires.

Donc, par similitude à ces tumeurs gingivales, on a cette saut muqueuse qui est truffée au niveau de la cavité buccale et de glandes salivaires accessoires. Il y a des glandes salivaires qui sont principales, la parotide, submandibulaire et sublinguale. Les glandes salivaires principales ont comme rôle la sécrétion et la excrétion salivaires réactionnelles.

En tenant un bol alimentaire dans la bouche, on déverse la salive submandibulaire et sublinguale qui est visqueuse pour favoriser la trituration et la mastication. Juste avant la déglutition, il y a l'excrétion d'une salive parotidienne qui est enzymateuse, qui est muqueuse. Elle est séreuse, muqueuse, c'est la submandibulaire, sublinguale, qui est moins visqueuse, qui est riche en enzymes pour commencer déjà la digestion chimique.

Les glandes salivaires accessoires ont comme rôle la salivation permanente, chronique pour l'humidification de la bouche. Si vous mordiez la face interne d'un lèvre inférieur, vous allez sentir des petites boules. C'est les glandes salivaires accessoires.

Que ce soit au niveau de l'agence, face interne de joues, palais, tout ce que vous voulez, on a ces petites glandes avec un ostium et un canal excréteur. On peut avoir des tumeurs malignes d'origine salivaire qui vont rapidement envahir l'os, généralement le palais. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des tumeurs malignes d'origine salivaire au niveau maxillaire.

On vous dit cylindrome. Cylindrome, c'est au niveau de la parotide. Non, on a un cylindrome qui est dû aux glandes salivaires accessoires.

Pourquoi ? Parce qu'il y a des glandes salivaires accessoires qui sont collées au squelette maxillaire. Donc, on a un petit chouïa, le propos précédent, pour approfondir les causes

histologiques des tumeurs. Quoi ? On a parlé d'hépithélium gingival.

On a parlé de glandes salivaires accessoires. Il y a les constituants de l'os, ostéocytes, ostéoblastes, fibroblastes. Tout ce qui est tissu mesenchymateux classique de l'os va donner des sarcomes.

Tout ce qui est tissu tout ce qui est épithélium de surface, des carcinomes, des carcinomes, des sarcomes. Il y a des sarcomes ostéosarcomes, fibrosarcomes, chondrosarcomes, oncosarcomes, les lymphomes. Et puis, nous ne l'oublions pas, les tumeurs malines ou dentogènes.

Tout ce qu'on a vu précédemment peut être d'emblée valable ou secondairement dégénéré. Donc, il y a un risque de générosité maligne, minime, mais existant, des tumeurs odontogéniques des maxillaires. Alors, les circonstances de découverte, c'est l'image en miroir de ce qu'on a vu précédemment.

Précédemment, on a vu des tumeurs bénignes, des tumeurs qui sont aussi symptomatiques. C'est des tumeurs qui sont calmes. Ceux-là, c'est des tumeurs qui sont bruyantes et qui font parler d'elles.

Donc, c'est un processus expansif, rapidement expansif, qui présente d'emblée des signes de complications hémorragiques, fractures, la surinfection et les complications respiratoires parce que ça évolue tellement rapidement, ça se fait facilement. D'accord, ça donne des douleurs, des névralgies et on a une perte spontanée des dents. Apparence saine des processus et on a une adénopathie.

Vous voyez que le tableau clinique, il est diamétralement opposé par rapport aux précédents. Donc, on dit que c'est des tumeurs qui sont une complication. C'est des tumeurs qui sont bruyantes.

C'est des tumeurs qui font parler d'elles. L'examen physique, lui, va retrouver un syndrome tumoral malin clinique, donc toujours masse profonde faisant corps avec l'os, il y a la douleur. La douleur, elle fait partie, on ne va pas attendre la complication pour voir la douleur apparaître.

Il est douloureux, il y a des névralgies. Rapidement, on peut avoir une anesthésie, c'est le fameux signe de Vincent. Monsieur Vincent a donné son nom à l'hypoesthésie qui est due aux tumeurs malignes des maxillaires.

Donc, nos confrères Maxillo et ORL utilisent le signe de Vincent comme ça à tort pour Donc, on a l'anesthésie secondaire au signe de Vincent, au fracture. Monsieur Vincent, une mobilité. On a une mobilité des dents.

D'accord? On a des dents qui bougent. Et ça saigne. On a une tendance de la fixité des parties molles.

Donc, il y en a une adénopathie au plan adénopathie pour les carcinomes et les lymphomes. Les sarcomes donnent des adénopathies à présence. Quand on a un sarcome, est ce qu'on est obligé? Nos chirurgiens d'aller faire un curage ganglionnaire? Quand il s'agit de carcinome ou c'est l'exercice humain.

Écrivez le sarcome, pas de métastase ganglionnaire. Vous ouvrez, vous faites une biopsie, vous trouvez, vous tombez sur un lymphome, vous opérez, vous faites une exercice chirurgicale. Non, c'est de la chimiothérapie.

La chirurgie va s'adresser aux vestiges tumorales qui résistent à la chimiothérapie. D'accord, carcinome, exercice tumoral, curage et reconstruction. Sarcome, exercice tumoral, reconstruction, lymphome, biopsie, chimiothérapie, chirurgie, entre guillemets.

D'accord, en ce qui concerne les moyens d'imagerie, on a un syndrome tumoral malin radiologique. On a des limites nettes, ici, c'est des limites qui sont floues. Avant, on avait dit qu'il y avait un liseré de sécurité, maintenant, non.

Corticales rompues, on a vu tout à l'heure quelques cas de tumeurs rompues, mais c'est des corticales qui sont tellement amincies qu'ils paraissent rompues. Mais là, la rupture, elle est réelle. Pendant un envahissement, tout à l'heure, on a vu un canal qui a été étudié, vous pouvez le suivre du début à la fin, c'est un tumeur malin, c'est un envahissement qui est réel.

Réaction périostée, et rappelez-vous, aspect de dent suspendue. La TDM, pareil, elle s'impose pour voir l'extension et le rapport, c'est pour la stratégie thérapeutique. Comme vous voyez là, dans l'IRM, il y avait peu de place.

D'accord? Ici et là, de la place parce qu'il y a une extension vers les parties molles. L'IRM est là, elle est plus performante que la TDM pour les parties molles. Elle est plus performante pour étudier les extensions vers la base du crâne, la fosse infracamporale et l'orbite.

Elle a aussi un intérêt quand on a un doute ou une récurrence après chirurgie. D'accord? On peut déceler soit une fibrose cicatricielle et la différencier avec une récurrence réelle. D'autres examens peuvent être demandés.

C'est un examen à radioisotope, c'est une injection du glucose irradié marquée. Et là où il y a une activité biologique importante, il y a une forte consommation du glucose et ça fixe le glucose. Donc, on peut savoir s'il a une métastase au niveau d'Urachis crâne.

D'accord, pelvis et ainsi de suite. A défaut, à défaut, on peut indiquer la scintigraphie, mais je pense que le scan est en train de se généraliser un peu partout. Rappelez vous le scan, comme toute tumeur pathologie maligne, il a sa place pour les tumeurs qui sont évolués dans les stades évolutifs.

C'est la fameuse quantification TNM que vous en trouvez sur Internet complications, pareil, fracture. Dans cellulite, examine génique et visibilité à l'échelle et les complications, donc la classification en rapport avec la compression des voies aérodigestives et sont beaucoup plus présentes par rapport aux tumeurs bénignes. Il faut savoir que les tumeurs bénignes, le patient concerné, il a plus de temps dans son organisme.

Il a plus de temps à s'acclimater avec la présence d'un volume au niveau de ses voies aérodigestives supérieures. Il s'habitue, son corps s'habitue, l'asphyxie ne survient pas. Les tumeurs malignes, parce que ça évolue tellement rapidement, ça obstrue les vents aérodigestifs.

L'asphyxie est les plus marquées. L'hémorragie, bien sûr. Il y a plus d'hémorragie que les tumeurs malignes, que les tumeurs pénines.

La prise en charge de ces tumeurs ne se conçoit pas comme une prise en charge, c'est le principe de carcinologie, c'est-à-dire une exérèse avec des marges. Une exérèse tumorale pour traiter la tumeur, des extensions loco-régionales. Donc, rappelez-vous, le curage ganglionnaire n'existe pas quand il s'agit de sarcom.

La reconstruction est toujours de mise. Il ne faut pas oublier les traitements ambulants, c'est-à-dire la chimiothérapie, la radiothérapie, même au post-opératoire, sur les lits tumoraux et les lits cervicales. Toujours l'importance de l'examen anatomopathologique et surtout des limites d'exérèse jusqu'à carcinologique.

Parce que des fois, on a une pièce qui est mal orientée en tridimensionnelle. En faisant des biopsies per opératoire des limites d'exérèse, on oriente l'anatome pathologiste pour examiner des régions dans lesquelles nous voulons faire attention et sur lesquelles, des fois, on a du doute sur les limites d'exérèse chirurgicale. Le pronostic, lui, dépend du type histologique.

Il y a des tumeurs qui sont plus méchantes que d'autres du stade évolutif. Vous imaginez qu'un T1 est plus favorable qu'un T3. La qualité d'exérèse est une terrain sous-jacente.

On va classer les tumeurs qui sont extirpables, les tumeurs métastatiques et l'adénopathie métastatique. Écrivez-le quelque part. L'air d'aller comme c'est très important.

Le pronostic morphofonctionnel se trouve au niveau du site de la tumeur. On va lui enlever une partie de son arcade dentaire, on va lui enlever une partie de sa mandibule. La morphologie va être compromise et la fonction va être compromise.

Pronostic morphofonctionnel, c'est au niveau du site de la tumeur. Pronostic vital, c'est au niveau des ganglions. C'est pour ça que quand on dit que quand on a une des métastases ganglionnaires d'une tumeur maxillaire, on sait que le patient a un mauvais pronostic.

Quand on enlève des ganglions, quand on en laisse d'autres, on sait que le patient a été

moyennement opéré. Généralement, c'est une adénopathie qui va pousser, qui va éroder un grand axe vasculaire et qui va mourir par une hémorragie cataclysmique. Pronostic fonctionnel, tumeur.

Pronostic vital, ganglion cervical. Ce sera tout.